Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Sémiologie cardio-vasculaire
les signes fonctionnels
la dyspnée

Pr Ouail D. MCA
ouailouailbejaia@gmail.com

Introduction

- Trois signes fonctionnels qui témoignent de l’atteinte cardiaque:
  - La dyspnée
  - La douleur précordiale
  - Les palpitations

Introduction

- Trois signes fonctionnels qui témoignent de l'atteinte cardiaque:
  - La dyspnée
  - La [illegible]
  - Les pal[illegible]

Définition

- Pour le médecin: dyspnée
- signe fonctionnel majeur
- une perception consciente d'une gêne respiratoire

Définition

Le malade et l’entourage:

- respiration rapide
- expiration difficile
- nécessité de se concentrer sur sa respiration
- respiration peu profonde
- respiration nécessitant un travail, un effort ;
- suffocation ;
- besoin d’air ;
- lourdeur dans la poitrine ;
- halètement

Étude sémiologique

Interrogatoire

- La date de début
- Le mode de début
- Les circonstances d’apparition
- L’évolution dans le temps
- L’horaire dans le nychtémère
- L’existance de signes accompagnateurs: douleurs thoraciques, palpitations, signes respiratoires …

Interrogatoire

Classification NYHA

Stade 1 : Absence de signes fonctionnels lors de l'activité physique habituelle.

Stade II : Présence de signes fonctionnels lors des efforts habituels.

Stade III : Présence de signes fonctionnels pour des efforts légers.

Stade IV : Présence de signes fonctionnels au repos

Types de la dyspnée d'origine cardiaque

- La dyspnée d'effort: la plus fréquente +++
- La dyspnée paroxystique:
  - Œdème aigu du poumon
  - Asthme cardiaque
- La dyspnée permanente: dyspnée du repos

Types de la dyspnée d'origine cardiaque

- La dyspnée aigue: embolie pulmonaire (voir sémiologie respiratoire)
- La fausse dyspnée: dyspnée périodique de Cheyne-Stokes (voir sémiologie respiratoire)

La dyspnée d'effort

- La dyspnée d'effort et la fatigue sont les deux symptômes principaux d'une défaillance cardiaque chronique
- Les caractères sémiologiques ne permettent pas l'orientation étiologique (pulmonaire, cardiaque, anémie …)

La dyspnée d'effort

Essoufflement physiologique:

- Effort inhabituel
- Cède rapidement
- S'adapte avec l'entrainement

La dyspnée d'effort

Caractéristiques :

Polypnée Survenant pour :

- effort habituel: dyspnée modérée
- Effort moindre: dyspnée importante
- Ne cède pas rapidement
- S'aggrave progressivement.

La dyspnée paroxystique

Caractéristiques :

- Crise d'apparition brutale
- Durée variable: quelques minutes à quelques heures
- Survenant au repos +++, la nuit ++++, rarement à l'effort

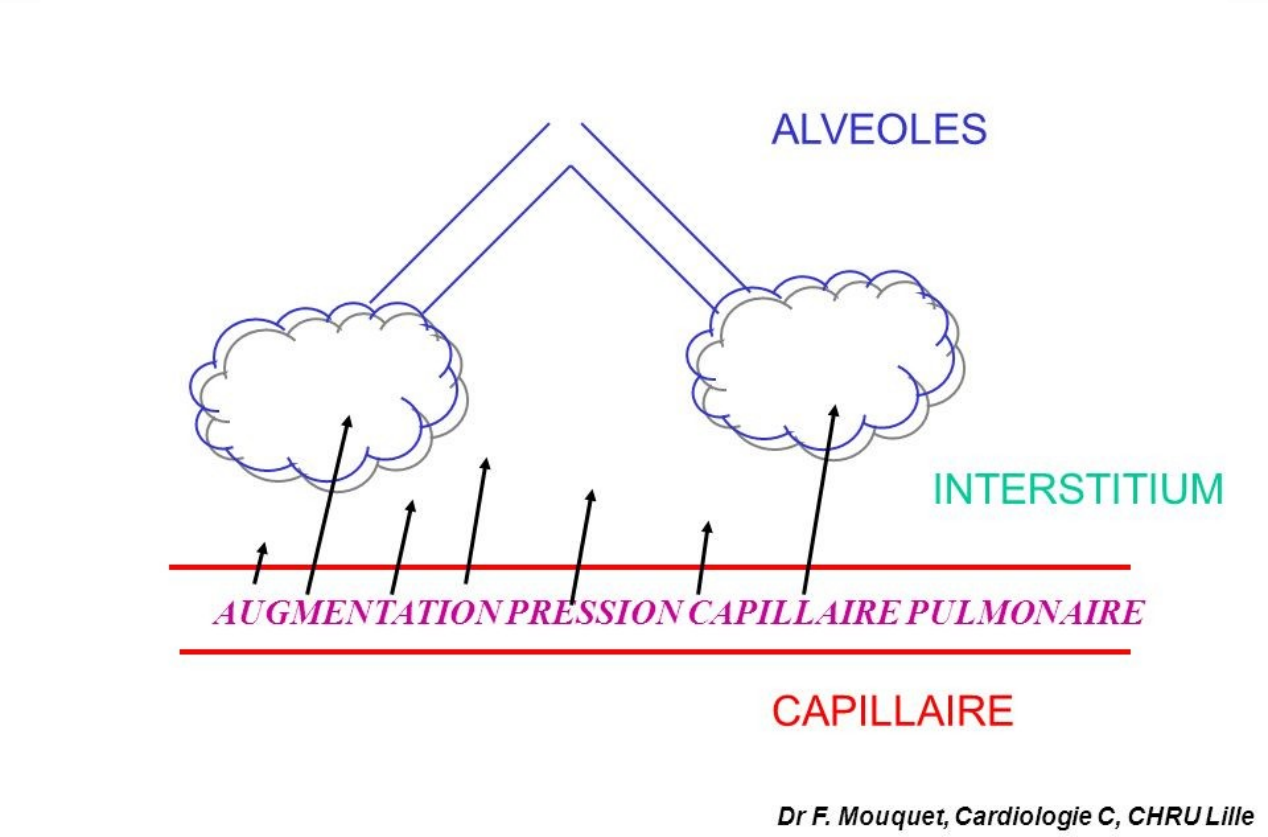
La dyspnée paroxystique

OAP :

- Plusieurs formes:
- Cas typique: la grande crise d’AOP
- Transsudation du sérum dans les alvéoles

OAP

PHYSIOPATH: OAP cardiogénique



Clinique

Début :

- Brutal
- La nuit
- Oppression d’aggravation rapide
- un chatouillement laryngé
- une toux

Clinique

Phase d'état : en quelques minutes.

- malade est assis au bord du lit
- couvert de sueur,
- le teint blafard,
- cyanose,
- les jugulaires turgescentes.

Clinique

Phase d’état : Trois signes majeurs:

- La polypnée:
- La toux
- L’expectoration séreuse

Clinique

Phase d'état : Trois signes majeurs:

- La polypnée:
  - intense,
  - angoissante avec orthopnée,
  - sensation de grésillement laryngé;
  - pas de point de côté.

Clinique

Phase d'état : Trois signes majeurs:

- La [illegible]
- La toux
  - incessante, quinteuse, pénible,
  - qui ramène rapidement

Clinique

Phase d’état : Trois signes majeurs:

- La [illegible]
- La [illegible]
- L’expectoration séreuse
  - Mousseuse, rosée saumonée, très abondante sans soulagement du patient

Clinique

Phase d’état :

- Auscultation :
  - râles crépitants
  - La marée montante
- tachycardie
- Autres signes d ’Insuffisance cardiaque : galop, oligurie,

Clinique

Phase d’état :

- Signes de gravité:
  - sueurs, marbrures,
  - troubles de conscience,
  - bradypnée, balancement thoraco-abdominal,
  - hypotension artérielle, oligurie

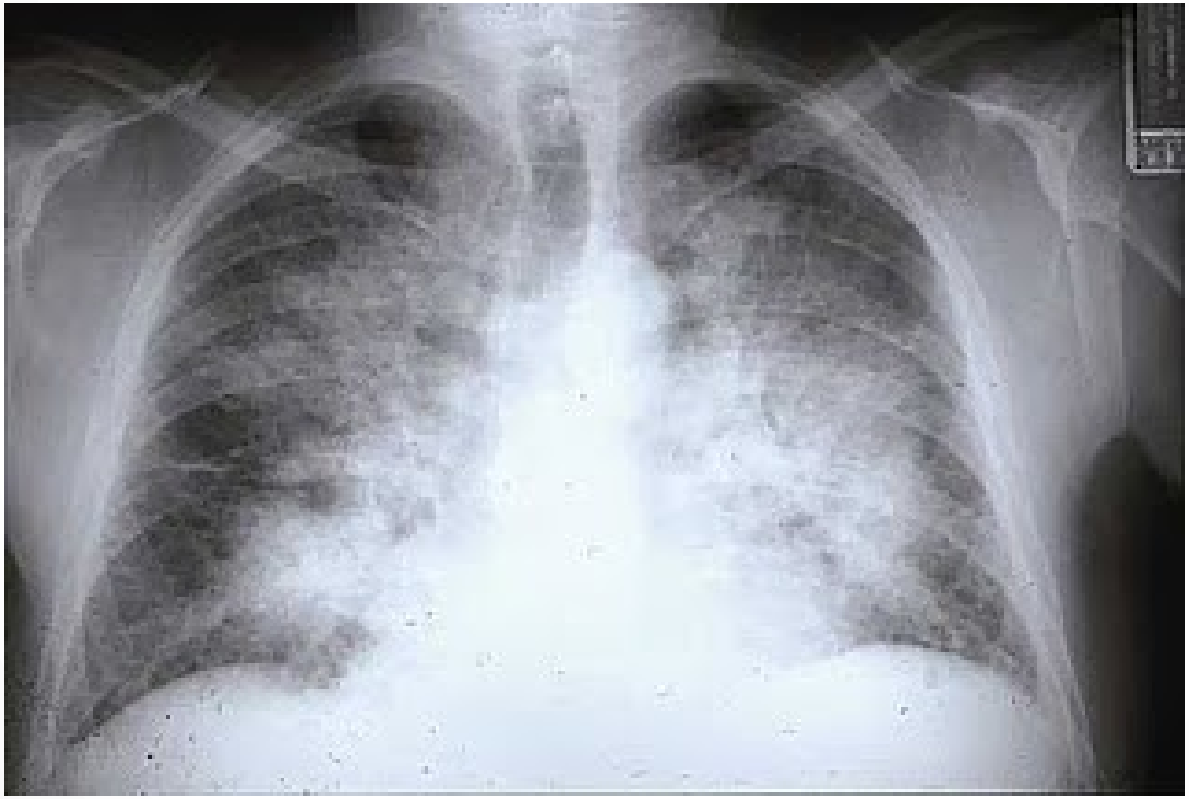
Radiologie

Radio du thorax:

- opacités nodulaires floconneuses bilatérales à prédominance péri-hilaire,

en ailes de papillon

Aspect en ailes de papillon



Asthme cardiaque

Caractéristiques

- *Il s'agit d'une crise dyspnéique à début brutal*
- *le plus souvent nocturne*
- *réalisant* une bradypnée expiratoire
- *thorax bloqué en inspiration et soif d'air intense.*
- *L'auscultation retrouve des sifflements expiratoires :* les râles sibilants *disséminés dans les deux champs pulmonaires.*
- *L'évolution : la crise se termine par quelques secousses de toux qui ramènent quelques crachats muqueux blanchâtres visqueux.*

Diagnostic

- Le diagnostic est posé sur l'examen du cœur et des vaisseaux entre les crises
- on retrouve soit une cause cardiaque ou vasculaire d'insuffisance ventriculaire gauche, soit un rétrécissement mitral.
- Dans le cas de l’asthme bronchique l’examen cardio vasculaire est normal

La dyspnée permanente ou dyspnée de repos

Caractéristiques

- Signifie la diminution importante du débit cardiaque
- augmente par le décubitus
- à recrudescence nocturne
- partiellement soulagée par la position assise ou demi assise réalisant *l'orthopnée.*
- L'interrogatoire précise son intensité par le nombre d'oreillers nécessaires au malade,
- au maximum le malade reste assis chaque nuit dans un fauteuil.